

MANAJEMEN NYERI KENYAMANAN PADA PASIEN KANKER PAYUDARA

Lia Fadlilah • Tintin Sukartini
Hanik Endang Nihayati



MANAJEMEN NYERI: KENYAMANAN PADA PASIEN KANKER PAYUDARA

Lia Fadlilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.

Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Manajemen Nyeri: Kenyamanan Pada Pasien Kanker Payudara

Penulis: Lia Fadlilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.

Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7097-81-1

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini yang berjudul **Manajemen nyeri: kenyamanan pasien kanker payudara.**

Gejala yang sering muncul pada pasien kanker payudara salah

satunya yaitu nyeri, gejala tersebut muncul sebelum pasien di rawat, paska tindakan dan atau selama perawatan di Rumah Sakit. Meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara salah satunya dapat dilakukan dengan manajemen nyeri dengan menggunakan pendekatan *theory of unpleasant symptoms dan theory of comfort.*

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan buku. Terimakasih kami ucapkan kepada rekan sejawat, para pakar dan keluarga yang selalu memberikan semangat, masukan dan kritikan yang membangun. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara. Segala kritik, koreksi, dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan buku ini.

November, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 KANKER PAYUDARA	7
A. Definisi	7
B. Patofisiologi	7
C. Stadium	8
D. Klasifikasi.....	9
E. Faktor Risiko	11
F. Tanda dan Gejala	14
G. Pencegahan.....	15
H. Penatalaksanaan.....	16
I. Komplikasi	19

BAB 3 TEORI KEPERAWATAN.....	21
A. Theory of Unpleasant symptoms.....	21
B. Theory of Comfort.....	27

BAB 4 MANAJEMEN NYERI	37
A. Definisi Nyeri	37
B. Karakteristik Nyeri	37
C. Mekanisme Nyeri.....	40
D. Tahapan Nyeri.....	41
E. Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri.....	42
F. Definisi Manajemen Nyeri	45

G. Manajemen Nyeri Fisik	45
H. Manajemn Nyeri Psikologis	47
I. Manajemen Nyeri Spiritual.....	48

BAB 5 PENUTUP.....	51
---------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	63
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	69
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak di dunia setelah kanker paru-paru (Sung et al., 2021). Sebagian besar pasien yang didiagnosis dengan kanker payudara akan mengalami efek dari rangkaian pengobatan atau disebabkan oleh proses penyakit itu sendiri (Costa et al., 2017). Salah satu gejala yang paling umum dialami yaitu nyeri. Nyeri kanker melibatkan komponen fisik, sosial, psikologis dan spiritual yang biasa disebut dengan nyeri yang bersifat multidimensi. Nyeri yang tidak dikelola dengan baik dan tidak berangsur berkurang dapat berdampak pada fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kontribusi masing-masing komponen bervariasi berdasarkan faktor individu dan keadaan yang dihadapi pasien. Respon yang umum ditunjukan terganggunya masalah psikologis yaitu kecemasan dan depresi. Secara sosial, nyeri menyebabkan ketergantungan dan gangguan hubungan dengan orang lain (Al-Mahrezi, 2017).

Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kenyamanan merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan yang dapat dicapai melalui perawatan yang berpusat pada pasien. Selain itu, kenyamanan adalah konsep holistik yang perlu diimplementasikan oleh tim keperawatan multidisiplin. Teori kenyamanan pertama kali dikemukakan oleh Katherine Kolcaba pada tahun 1998.

Berdasarkan teori ini, keadaan nyaman perlu dinilai, dan jika pasien mengalami ketidaknyamanan, perawat perlu menerapkan intervensi dan mengevaluasi skor kenyamanan sebelum dan sesudah intervensi untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman yang spesifik meliputi fisiologis, psikologis, sosiospiritual dan lingkungan (Alligood, 2014). Pengendalian nyeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara. Manajemen nyeri non farmakologis dalam kenyataanya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi perawat, hal ini berkaitan dengan perbedaan persepsi nyeri yang dialami oleh pasien. Perbedaan ini akan cenderung menyulitkan perawat untuk melakukan diagnosa dan manajemen nyeri pada pasien. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan manajemen nyeri non farmakologis. Manajemen nyeri pada pasien kanker payudara membutuhkan evaluasi secara menyeluruh dan penilaian kritis terhadap nyeri. Penyebab sebenarnya dari nyeri harus dikenali, sehingga manajemen dapat disesuaikan untuk setiap pasien.

Manajemen nyeri non farmakologis seperti intervensi perawatan fisik, intervensi manajemen diri dan pembinaan, intervensi perilaku kognitif, dan intervensi berbasis teknologi atau intervensi keterampilan coping memiliki efek terbatas dan jangka pendek dalam mengurangi rasa sakit di antara pasien. Manajemen nyeri kanker payudara didasarkan pada penilaian nyeri rutin yang cermat dan evaluasi pasien yang tepat baik secara fisik maupun psikologis. Penilaian yang cermat dari karakteristik nyeri dapat menghasilkan manajemen nyeri kanker payudara yang sempurna, dan intensitas nyeri yang dilaporkan

oleh pasien dianggap sebagai standar untuk penilaian nyeri. Penilaian nyeri yang komprehensif sangat penting untuk manajemen nyeri yang efektif. Dengan demikian, manajemen nyeri yang efektif tergantung pada skrining reguler untuk pengenalan awal nyeri. karakterisasi nyeri yang akurat seperti onset atau awitan, durasi (akut atau kronis), intensitas, lokasi, keparahan. Faktor lain termasuk riwayat, manajemen nyeri sebelumnya, prognosis pasien, komorbiditas, risiko penyalahgunaan obat nyeri, preferensi pasien, dan faktor prediktif lainnya, seperti tekanan psikologis.(Alhazmi et al., 2021).

Selain manajemen fisik dan psikologis, manajemen psikososial secara khusus menangani perasaan, pikiran, dan perilaku. intervensi psikososial memiliki efek menguntungkan pada kualitas hidup dan hasil kesehatan psikologis lainnya pada pasien kanker di semua tahap penyakit. Mempertimbangkan komposisi tim multi-profesional dalam perawatan paliatif, penting untuk mengevaluasi berbagai pilihan pengobatan dari perspektif biopsikososial. (Warth et al., 2020). Menurut hasil penelitian manajemen nyeri berbasis spiritual yang paling banyak digunakan dalam penanganan nyeri pada pasien kanker yaitu terapi murottal, do'a, dan dzikir (Risdawati, 2020).

Teori comfort dapat diaplikasikan terutama pada pasien yang mengalami nyeri dan pasien dengan peningkatan skala nyeri yang dipengaruhi kecemasan. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sesuatu yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan (Alligood, 2014). Menurut hirarki Maslow tingkat yang paling dasar dalam kebutuhan

dasar manusia meliputi kebutuhan fisiologis seperti udara, air, makanan, tempat tinggal, rasa nyaman, eliminasi, seks, istirahat dan tidur. Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan keselamatan dan kenyamanan yang melibatkan fisik dan psikologis menjadi tingkatan yang kedua (Potter & Perry, 2010). Berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan keperawatan. Konsep kenyamanan memiliki subjektif yang sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri.

Penanganan gejala-gejala yang muncul akibat kanker juga membutuhkan penanganan pada semua perubahan untuk menggunakan penerapan teori keperawatan. Teori keperawatan yang dapat diaplikasikan pada klien kanker payudara untuk menyelesaikan keluhan fisik, psikologis dan situasionalnya adalah *Theory of unpleasant symphoms* (Mikšić et al., 2018). *Theory of unpleasant symphoms* (TOUS) adalah teori dalam perawatan kesehatan dikembangkan oleh petugas kesehatan dan dimaksudkan untuk diterapkan pada pasien. Menurut teori ini, beberapa gejala dapat terjadi secara bersamaan, berinteraksi satu sama lain dan menjadi multiplikatif. Kelompok gejala yang saling mempengaruhi disebut cluster gejala dengan mengontrol satu gejala, kita bisa mengontrol yang lain gejala. Munculnya gejala adalah dikondisikan oleh fisiologis, psikologis dan faktor lingkungan. *Theory of unpleasant symphoms* menekankan kompleksitas gejala, sementara juga menyiratkan

kemungkinan pencegahan dan strategi manajemen. *Theory of unpleasant symphoms* memiliki tiga kategori terkait dari faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi terjadinya satu atau lebih gejala dan cara menanganinya. Gejala tersebut dapat mempengaruhi pengalaman gejala. Teori ini tidak memasukkan intervensi eksplisit. Sebaliknya, diasumsikan banyak komponen dan hubungan pada *Theory of unpleasant symphoms* dapat ditargetkan untuk intervensi (Lenz, 2018). Berdasar permasalahan tersebut, dapat disimpulkan manajemen nyeri sangat penting dilakukan untuk memberikan perawatan pada pasien kanker payudara dengan nyeri sehingga mampu meningkatkan kenyamanan.

BAB 2

KANKER PAYUDARA

A. Definisi

Kanker payudara merupakan sel-sel ganas (kanker) terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara atau yang biasa disebut juga dengan *Carcinoma Mammarum* yang merupakan tumor ganas tumbuh di dalam jaringan payudara. Tumor ini dapat tumbuh dan berkembang dalam kelenjar payudara, saluran payudara, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara (Harbeck et al., 2019).

B. Patofisiologi

Kanker payudara berkembang karena kerusakan DNA dan terjadi mutasi genetik dipengaruhi oleh paparan estrogen. Terkadang akan ada pewarisan abnormal DNA atau gen pro-kanker seperti BRCA1 dan BRCA2. Dengan demikian riwayat keluarga kanker ovarium atau payudara meningkatkan risiko perkembangan kanker payudara. Pada individu normal, sistem kekebalan menyerang sel-sel dengan DNA abnormal atau pertumbuhan abnormal. Ini gagal pada mereka dengan penyakit kanker payudara yang menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran tumor (Alkabban & Ferguson, 2021).

C. Stadium

Stadium menentukan ketepatan lokasi kanker dan derajat metastasisnya saat didiagnosa. Berikut penjelasan stadium pada kanker, yaitu:

1. Stadium 0

Stadium 0 yaitu menunjukkan karsinoma in situ. Tis, N0, M0.

2. Stadium I

Stadium I yaitu menunjukan kanker terlokalisasi. T1-T2, N0, M0.

3. Stadium II

Stadium II yaitu menunjukan kanker stadium lanjut lokal atau stadium awal. T2-T4, N0, M0.

4. Stadium III

Stadium III yaitu menunjukan kanker stadium lanjut lokal atau stadium lanjut. T1-T4, N1-N3, M0.

5. Stadium IV

Stadium IV yaitu menunjukan Kanker metastatik. T1-T4, N1-N3, M1

Stadium menggambarkan tingkatan yang didasarkan pada ukuran lesi primer, penyebaran ke kelenjar limfe dan ada atau tidaknya metastase melintasi jalur darah, dimana stadium kanker juga akan mempengaruhi pilihan terapi. Cara yang paling umum dalam menentukan stadium kanker yaitu berdasarkan sistem TNM. Pada sistem TNM dinilai tiga faktor utama yaitu tumor size (T) atau ukuran tumor, node (N) atau kelenjar limfe regional dan metastase (M) atau Penyebaran (Rosen & Sapra, 2022).

1. Tumor (T)

T dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran tumor primer dan invasinya ke jaringan yang berdekatan. T0 menunjukkan bahwa tidak ada bukti tumor, Tx digunakan ketika tumor tidak dapat dinilai, sedangkan T1-T4 digunakan untuk mengidentifikasi ukuran dan perluasan tumor, dengan pembesaran progresif dan invasi dari T1 ke T4.

2. Node (N)

N dapat digunakan untuk menggambarkan keterlibatan kelenjar getah bening regional tumor. Kelenjar getah bening berfungsi sebagai filter biologis, karena cairan dari jaringan tubuh diserap ke dalam kapiler limfatik dan mengalir ke kelenjar getah bening. N0 menunjukkan tidak ada penyebaran nodal regional, sedangkan N1-N3 menunjukkan beberapa derajat penyebaran nodal, dengan penyebaran distal secara progresif dari N1 ke N3.

3. Metastasis (M)

M dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya metastasis jauh dari tumor primer. Metastasis adalah ketika tumor menyebar di luar kelenjar getah bening regional. Tumor diklasifikasikan sebagai M0 jika tidak ada metastasis jauh dan M1 jika ada bukti metastasis jauh.

D. Klasifikasi

Klasifikasi kanker payudara, yaitu:

1. Klasifikasi histologis

Klasifikasi histologis menjadi dasar klasifikasi kanker payudara oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Tan et al., 2020).

Berikut adalah klasifikasi histologis edisi ke-5:

- a. Neoplasia lobular non invasif
 - Karsinoma lobular in situ (klasik, kemerahan, pleomorfik)
- b. Karsinoma duktal in situ (DCIS)
 - 1) DCIS tingkat nuklir rendah
 - 2) DCIS tingkat nuklir menengah
 - 3) DCIS tingkat nuklir tinggi
 - 4) Karsinoma payudara invasif (IBC)
 - 5) Karsinoma payudara invasif tanpa tipe khusus (NST)
 - 6) Karsinoma mikroinvasif
 - 7) Karsinoma lobular invasif
 - 8) Karsinoma tubuler
 - 9) Karsinoma kribriiformis
 - 10) Karsinoma musinosa
 - 11) Cystadenocarcinoma musinosa
 - 12) Karsinoma mikropapiler invasif
 - 13) Karsinoma dengan diferensiasi apokrin
 - 14) Karsinoma metaplastik
 - 15) Karsinoma sel asinik
 - 16) Karsinoma kistik adenoid
 - 17) Karsinoma sekretori
 - 18) Karsinoma mukoepidermoid
 - 19) Adrenokarsinoma polimorf
 - 20) Karsinoma sel tinggi dengan polaritas terbalik
- c. Neoplasma neuroendokrin
 - 1) Tumor neuroendokrin grade 1 dan grade 2
 - 2) Karsinoma neuroendokrin

- d. Neoplasma papiler
 - 1) Karsinoma duktal papiler in situ
 - 2) Karsinoma papiler berkapsul
 - 3) Karsinoma padat (in situ dan invasif)
 - 4) Karsinoma papiler invasif
- e. Neoplasma epitel-mioepitel
 - 1) Adenomioepithelioma maligna
 - 2) Karsinoma epitel mioepitel
- f. Tumor payudara pria
 - 1) Karsinoma in situ
 - 2) Karsinoma invasif
- 2. Kanker payudara luminal
- 3. Kanker payudara yang diperkaya HER2
- 4. Kanker payudara triple negatif
- 5. Kanker payudara claudin low

E. Faktor Risiko

Faktor risiko yang dapat memicu terjadinya kanker payudara diantaranya:

1. Jenis kelamin

Kanker payudara merupakan penyakit yang jarang terjadi pada pria (Momenimovahed & Salehiniya, 2019).

2. Usia

Selain jenis kelamin, usia merupakan salah satu faktor risiko kanker payudara yang paling penting, karena kejadian kanker payudara sangat terkait dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, pemeriksaan mamografi perlu dilakukan terlebih dahulu pada wanita berusia 40 tahun ke atas (Sun et al., 2017). Angka kejadian kanker payudara meningkat secara signifikan dengan

bertambahnya usia dan mencapai puncaknya pada usia menopause dan kemudian secara bertahap menurun atau tetap konstan (Momenimovahed & Salehiniya, 2019).

3. Sejarah keluarga

Faktor genetik yang berkontribusi dalam kejadian kanker payudara yaitu mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 yang diturunkan melalui metode autosomal dominan (Momenimovahed & Salehiniya, 2019). Hampir seperempat dari semua kasus kanker payudara berkaitan dengan riwayat keluarga. Wanita yang ibu atau saudara perempuannya menderita kanker payudara akan rentan terhadap kanker payudara. Kerentanan yang diturunkan dikaitkan dengan mutasi gen terkait kanker payudara seperti BRCA1 dan BRCA2 (Sun et al., 2017).

4. Faktor reproduksi

Faktor reproduksi seperti menarche dini, menopause terlambat, usia akhir kehamilan pertama dan paritas rendah dapat meningkatkan risiko kanker payudara (Sun et al., 2017). Usia menopause di atas 50 tahun dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Karakteristik kehamilan terutama pada kehamilan pertama memegang peranan penting dalam risiko berkembangnya kanker payudara, hal ini hampir dua kali lipat terjadi pada wanita yang melahirkan anak pertama mereka sebelum usia kehamilan 33 minggu (Momenimovahed & Salehiniya, 2019).

5. Metode kontrasepsi

Metode kontrasepsi oral dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian kanker payudara (Momenimovahed & Salehiniya, 2019). Kontrasepsi oral dan terapi suntik hormon (hormone replacement therapy/HRT) menjadi sumber utama yang menghasilkan

hormon estrogen eksogen. Estrogen endogen dan eksogen berhubungan dengan risiko kanker payudara. Estrogen endogen biasanya diproduksi oleh ovarium pada wanita premenopause dan ovariectomi dapat mengurangi risiko kanker payudara (Sun et al., 2017).

6. Gaya hidup

Gaya hidup seperti konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan kadar hormon terkait estrogen dalam darah dan memicu jalur reseptor estrogen (Momenimovahed & Salehiniya, 2019). Obesitas dan kelebihan berat badan dapat memicu kanker payudara karena tingkat konversi yang lebih tinggi dari prekursor androgenik menjadi estrogen melalui aromatisasi perifer di jaringan adiposa. Selain itu diet nonvegetarian atau diet tinggi lemak jenuh dapat menyebabkan kanker payudara (Sun et al., 2017). Sebagai wanita perokok aktif maupun pasif dapat berisiko terkena penyakit kanker payudara, meskipun hubungan antara merokok dan risiko kanker payudara masih kontroversial, mutagen dari asap rokok telah terdeteksi dalam cairan payudara dari wanita yang tidak menyusui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan pasangan terhadap perokok pasif merupakan faktor risiko berkembangnya kanker payudara, dan khususnya, hal ini berkontribusi terhadap peningkatan risiko kanker payudara positif ganda ER +/PR (Momenimovahed & Salehiniya, 2019).

F. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala kanker bermacam-macam yaitu efek lokal, efek sistemik serta metastasis. Istilah sindrom paraneoplastik digunakan untuk menjelaskan efek-efek sistemik kanker yang dibagi dalam enam kategori, yaitu:

1. Gangguan hematologis, imunologi, dan vaskular, misal masalah: anemia, trombositopenia, infeksi dan perdarahan.
2. Gangguan hormon dan endokrinologis, misal masalah: hipertiroidisme, sindrom cushing, kaheksia akibat meningkatnya glukoneogenesis.
3. Neuropati, misal masalah: kelemahan, gangguan serebral, neuritis perifer.
4. Gangguan kulit dan jaringan penyambung, misal masalah: dermatomiositosis.
5. Gangguan gastrointestinal, misal masalah: kelelahan, dan berat badan menurun.
6. Gangguan umum dan metabolik, misal masalah: asites dan efusi pleura. Gejala umum kanker biasanya tergantung pada jenis, tempat, dan stadium kanker.

Berikut tanda gejala yang muncul pada sebagian wanita dengan kanker payudara seperti benjolan pada payudara, kelainan puting susu, kelainan kulit payudara, benjolan pada ketiak, ulserasi payudara, kelainan kontur payudara, infeksi atau peradangan payudara, pembengkakan payudara, nyeri payudara, nyeri punggung, nyeri muskuloskeletal, penurunan berat badan, sesak nafas, ruam payudara, benjolan leher atau kelainan pada kelenjar getah bening, sakit perut, kelainan payudara lainnya, nyeri dada, kelemahan atau kelelahan, batuk, nyeri aksila, memar payudara, edema ekstremitas (Koo et al., 2017).

G. Pencegahan

Pencegahan yang dapat dilakukan pada pasien kanker payudara, yaitu:

1. Skrining

Deteksi dini yang dilakukan dapat dijadikan landasan pencegahan kanker payudara. Mammografi adalah metode skrining yang efektif dengan menggunakan sinar-X energi rendah untuk mendapatkan gambar payudara dengan resolusi tinggi. Seluruh proses pengujian hanya berlangsung selama 20 menit dan tidak memerlukan zat penambah kontras (Sun et al., 2017). Meskipun mamografi telah ditetapkan sebagai sarana untuk mengurangi kematian akibat kanker payudara, data mengenai nilai dari pendekatan pencegahan ini secara mengejutkan kontroversial, dengan ketidaksepakatan besar pada sejauh mana pengurangan angka kematian. (Golemis et al., 2018)

2. Kemoprevensi/ pencegahan kemo

Penggunaan agen farmakologis atau alami yang menghambat perkembangan kanker payudara invasif baik dengan memblokir kerusakan DNA yang memulai karsinogenesis, atau dengan menghentikan atau membalikkan perkembangan sel pra-ganas dimana kerusakan tersebut telah terjadi (Sun et al., 2017) Dua obat selektif reseptor estrogen modular (SERM), tamoxifen dan raloxifene, disetujui oleh FDA untuk mencegah kanker payudara pada wanita berisiko tinggi. SERM bertindak sebagai anti estrogen dalam beberapa sistem organ, dan dalam mode pro estrogenik pada yang lain. Tamoxifen adalah agen pertama yang disetujui, dan satu-satunya yang disetujui untuk digunakan pada wanita pra dan pasca menopause. Raloxifene disetujui sebagian

berdasarkan temuan dari percobaan prospektif acak yang membandingkan agen dengan tamoxifen. Pada saat percobaan dimulai, raloxifene sudah disetujui FDA untuk mengobati osteoporosis pada wanita pascamenopause. Oleh karena itu, percobaan yang membandingkan raloxifene dengan tamoxifen hanya melibatkan wanita pascamenopause (Sauter, 2018).

3. Pencegahan biologis

Pencegahan biologis atau yang dikenal dengan antibodi monoklonal untuk kanker payudara, telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara. Salah satu target utama antibodi monoklonal ini adalah HER2. Salah satu HER2 yang pertama disetujui FDA yaitu Trastuzumab. Beberapa mekanisme potensial mungkin bahwa trastuzumab dapat menekan pertumbuhan dan proliferasi sel kanker dengan merekrut ubiquitin untuk menginternalisasi dan menurunkan HER2, dengan mengaktifkan sistem kekebalan melawan sel kanker melalui mekanisme yang disebut antibodi-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) atau dengan menghambat jalur MAPK dan PI3K/Akt (Sauter, 2018).

H. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada pasien kanker payudara yaitu:

1. Terapi konservasi payudara (BCT)

Kontraindikasi BCT termasuk adanya klasifikasi difus yang mencurigakan atau tampak ganas, penyakit yang tidak dapat direseksi hingga batas negatif dengan hasil

kosmetik yang memuaskan, dan adanya kontraindikasi untuk pemberian radiasi seperti pengobatan sebelumnya pada bidang payudara atau skleroderma aktif (Moo et al., 2018).

2. Mastektomi

Beberapa jenis mastektomi yaitu mastektomi total (mastektomi sederhana), mastektomi skin-sparing, dan mastektomi areolar-sparing (Moo et al., 2018).

- a. Mastektomi total yaitu dengan menghilangkan parenkim payudara, kompleks areolar puting susu, dan kulit berlebih dari dinding dada, hanya menyisakan kulit yang cukup untuk menutup sayatan. Biasanya digunakan ketika pasien tidak akan menjalani rekonstruksi segera.
- b. Mastektomi skin-sparing dikembangkan untuk memfasilitasi rekonstruksi segera, dan menghilangkan parenkim payudara dan kompleks areolar puting susu, meninggalkan kulit sebagai selubung alami untuk penempatan jaringan expander/implan atau flap autologus.
- c. Mastektomi areolar-sparing puting mempertahankan kompleks areolar puting selain selubung kulit dan awalnya digunakan terutama dalam pengaturan profilaksis, dan sekarang semakin banyak digunakan pada pasien dengan karsinoma invasif.

3. Radiasi pasca mastektomi (PMRT)

Radiasi pasca mastektomi adalah komponen pengobatan kanker payudara pada pasien dengan penyakit lanjut. Peran PMRT pada pasien dengan penyakit awal, serta mereka yang menjalani NAC, tetap dalam evolusi. Prediktor LRR yang paling penting setelah

mastektomi adalah luasnya penyakit nodus aksila (Moo et al., 2018).

4. Kemoterapi

Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker, baik dengan membunuh sel atau dengan menghentikan pembelahannya. Ketika kemoterapi dilakukan melalui mulut atau disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau otot, obat-obatan tersebut memasuki aliran darah dan dapat mencapai sel-sel kanker di seluruh tubuh (kemoterapi sistemik).

a. Kemoterapi neoadjuvant

Pada wanita dengan tumor besar relatif terhadap ukuran payudara, kemoterapi neoadjuvant (NAC) dapat digunakan untuk mengecilkan tumor (Moo et al., 2018).

b. kemoterapi adjuvant

Setelah reseksi bedah kanker payudara primer, pasien sering menerima terapi sistemik adjuvant dengan tujuan memberantas penyakit mikrometastatis yang secara klinis dan radiografis okultisme yang dapat berkembang menjadi penyakit metastasis nyata jika tidak diobati. Pemilihan terapi sistemik adjuvant didasarkan pada stratifikasi risiko pasien. Dua faktor yang mempengaruhi risiko: beban penyakit (jumlah kelenjar getah bening, ukuran tumor primer) dan biologi penyakit yang ditentukan oleh status HR dan HER2, dan uji genomik. Sementara pasien dengan kanker triple negatif dan kanker HER2 positif umumnya dianggap berisiko tinggi, ada keragaman biologis yang cukup besar di antara mereka yang memiliki kanker HR positif, kanker HER2 negatif (Moo et al., 2018).

5. Terapi biologis dan bertarget

Pasien dengan kanker payudara positif HER2 diberikan terapi target HER2 yang dikombinasikan dengan tulang punggung kemoterapi. Ketersediaan agen yang ditargetkan HER2 telah secara dramatis mengubah prognosis pasien dengan kanker payudara positif HER2. pasien dengan kanker payudara positif HER2 stadium I sering menerima regimen paclitaxel (T) dengan trastuzumab (H). stadium II-III HER2 positif menerima rejimen dengan trastuzumab yang ditambahkan ke AC-T (AC-TH) atau ke docetaxel dan carboplatin (DCbH) (Moo et al., 2018).

6. Terapi endokrin

Terapi endokrin direkomendasikan untuk sebagian besar pasien dengan penyakit HR positif. Pasien dapat diobati dengan terapi endokrin selama 5-10 tahun, dan mungkin lebih lama. Pasien dengan HR positif karsinoma duktal in situ dapat ditawarkan terapi endokrin untuk mengurangi kemungkinan kanker payudara di masa depan pada payudara yang terkena jika dipertahankan, dan pada payudara kontralateral. Tamoxifen dan inhibitor aromatase keduanya pilihan (Moo et al., 2018).

I. Komplikasi

Komplikasi dapat timbul dari pengobatan, baik kemoterapi, radiasi, terapi hormonal, maupun pembedahan (Alkabban & Ferguson, 2021).

1. Komplikasi bedah meliputi:
 - a. Infeksi
 - b. Nyeri
 - c. Berdarah
 - d. Masalah kosmetik

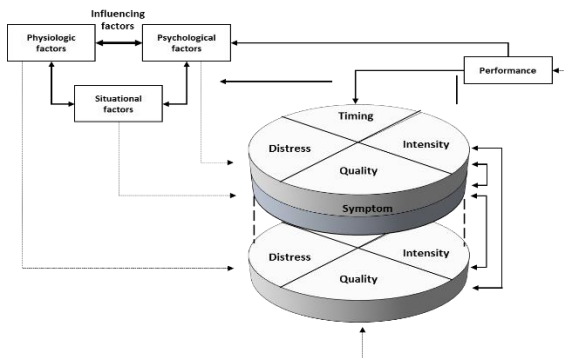
- e. Jaringan parut permanen
 - f. Perubahan atau hilangnya sensasi di area dada dan payudara yang direkonstruksi
2. Komplikasi kemoterapi meliputi:
 - a. Mual/muntah dan diare
 - b. Rambut rontok
 - c. Kehilangan memori
 - d. Kekeringan vagina
 - e. Gejala menopause/masalah kesuburan
 - f. Sakit saraf
 3. Komplikasi yang menyertai terapi hormonal meliputi:
 - a. Hot flash
 - b. Keputihan kering
 - c. Kelelahan
 - d. Mual
 - e. Impotensi pada pria penderita kanker payudara
 4. Radiasi dapat menyebabkan komplikasi berikut:
 - a. Nyeri dan perubahan kulit
 - b. Kelelahan
 - c. Mual
 - d. Rambut rontok
 - e. Masalah jantung dan paru-paru (jangka panjang)
 - f. Sakit saraf

BAB 3

TEORI KEPERAWATAN

A. Theory of Unpleasant symptoms

Theory Of Unpleasant Symptoms (TOUS) merupakan teori keperawatan middle range yang dikembangkan oleh Audrey Gift, Renee Milligan, Linda Pugh, dan Elizabeth Lenz. Teori ini bertujuan untuk diaplikasikan dan digunakan oleh perawat maupun peneliti klinis. Konsep ini muncul pertama kali pada tahun 1995 dan dimodifikasi pada tahun 1997. TOUS dikembangkan secara induktif mulai dari spesifik ke umum dan dari pengamatan nyata di lingkungan praktik keperawatan kedalam ide-ide teoritis. Artinya, hal itu dimulai dari lingkup yang relatif sempit, bermula dari gejala tunggal dan didasarkan pada kenyataan praktik (Liehr & Smith, 2014).



Gambar 3.1 Kerangka kerja konseptual
Theory of unpleasant symptoms (Lenz, 2018).

TOUS memiliki tiga konsep utama yaitu gejala, faktor-faktor yang mempengaruhi dan hasil kinerja. Gejala akan mempengaruhi suatu kinerja individu yang dapat memberikan umpan balik untuk mempengaruhi pengalaman gejala dan pengaruh dari faktor-faktor. Berikut tiga konsep *theory unpleasant symptoms*:

1. Variasi gejala

Variasi gejala didefinisikan sebagai indikator yang dirasakan sebagai perubahan fungsi normal seperti yang dialami oleh setiap pasien. Sifat dari gejala yaitu hanya dapat diketahui dan dijelaskan oleh individu yang mengalami. Gejala juga disebut konsep sentral yang merupakan titik awal dalam konsep TOUS. Teori ini telah berfokus pada gejala yang dirasakan secara subjektif daripada tanda-tanda yang dapat diamati secara objektif (Liehr & Smith, 2014).

Dua atau lebih gejala dapat terjadi bersamaan atau sebagai kluster gejala. Beberapa gejala yang terjadi bersama-sama mungkin memiliki gejala yang sama atau penyebab yang berbeda, dan dapat memiliki efek kumulatif atau multiplikasi (Lenz, 2018). TOUS telah diakui sebagai salah satu dari beberapa teori generik untuk mengatasi dan secara visual menggambarkan beberapa gejala yang dialami secara bersamaan (Liehr & Smith, 2014). Dalam TOUS, gejala dikonseptualisasikan sebagai manifestasi multiple dimensi variabel yang terukur. Ditegaskan bahwa semua gejala bervariasi dalam

intensitas atau keparahan, tingkat kesulitan terkait waktu, dan kualitas (Liehr & Smith, 2014).

- a. Intensitas adalah dimensi yang mengkuantifikasi derajat, kekuatan, atau keparahan gejala dan merupakan aspek yang paling sering diukur. Intensitas juga merupakan bagian dari penilaian rutin pasien pasca operasi untuk meminta mereka mengungkapkan intensitas atau tingkat keparahan nyeri dalam skala numerik atau pada skala analog visual (Liehr & Smith, 2014)
- b. Distres mencerminkan aspek afektif dari gejala, hal itu mengacu pada sejauh mana individu merasa terganggu dengan timbulnya gejala. Distres didefinisikan sebagai beban emosional yang disebabkan oleh gejala. Karena perbedaan tingkat ambang nyeri dan ekspektasi budaya, misalnya individu yang terpapar intensitas yang sama dapat menimbulkan rangsangan rasa sakit dengan tingkat penderitaan yang berbeda. Umumnya tingkat penderitaan yang dialami dengan suatu gejala berhubungan dengan intensitasnya. Namun, hal itu juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan lain seperti dipengaruhi oleh tingkat perhatian terfokus yang individu mengarahkan ke gejala. Manajemen gejala strategi yang dirancang untuk mengurangi penderitaan termasuk mengalihkan perhatian dari gejalanya (Liehr & Smith, 2014).
- c. *Timing* mencakup lamanya gejala timbul yang bervariasi dalam durasi, frekuensi, dan pola kejadian. *Timing* juga umum untuk membedakan gejala akut dan gejala kronis yang artinya strategi untuk mengelola gejala yang timbul juga akan

berbeda. Misalnya, strategi yang tepat untuk nyeri akut tidak selalu berhasil dalam mengobati nyeri kronis. Dimensi waktu juga memperhitungkan frekuensi atau kecepatan timbulnya gejala dan juga pola perubahannya dari waktu ke waktu atau berulang. Misalnya gejala yang intermiten dapat bervariasi dalam keteraturan dan periodik. Gejala persisten dapat bervariasi dalam intensitas dari waktu ke waktu (Liehr & Smith, 2014).

- d. Kualitas gejala merupakan dimensi terakhir dari gejala yang tergabung dalam TOUS. Dimensi ini mengacu pada sifat gejala atau cara gejala tersebut dimanifestasikan atau dialami. Dengan menyertakan dimensi ini, TOUS mencerminkan karakteristik yang umum di semua gejala, setiap gejala memiliki karakteristik unik. Misalnya rasa sakit sering ditandai dengan sifat sensasi, seperti menyengat, terbakar, menusuk, memukul, dan lain sebagainya (Liehr & Smith, 2014).

2. Faktor yang mempengaruhi

Terdapat tiga kategori dari faktor yang mempengaruhi gejala yang diidentifikasi dalam TOUS yaitu faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor situasional.

a. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis meliputi anatomi/struktural, fisiologis, variabel genetik, terkait penyakit, dan terkait pengobatan (Liehr & Smith, 2014). Faktor fisiologis meliputi usia, jenis kelamin, dan variabel yang berhubungan dengan penyakit dan pengobatan (Lenz, 2018).

b. Faktor psikologis

Faktor psikologis mewakili salah satu komponen model yang lebih kompleks. Faktor psikologis termasuk variabel afektif dan kognitif. Keadaan afektif atau suasana hati individu. Misalnya tingkat kecemasan, depresi, atau kemarahan) selama atau sebelum gejala bahkan jika tidak terkait dengan respon gejala dan emosi terhadap penyakit atau gejala itu sendiri dapat berfungsi untuk mengintensifkan gejala.

Variabel kognitif yang dapat mempengaruhi pengalaman gejala termasuk tingkat ketidakpastian yang melingkupinya, tingkat pengetahuan individu tentang penyakit atau gejalanya, arti dari gejala tersebut pengalaman kepada individu, dan repertoar kognitifnya keterampilan koping dan ketersediaan sumber koping yang dirasakan. Sebagai penelitian psikologis menggaris bawahi dasar fisiologis untuk suasana hati, menjadi semakin jelas bahwa psikologis dan faktor fisiologis yang mempengaruhi pengalaman gejala mungkin sulit untuk dipisahkan.

c. Faktor situasional

Faktor situasional bersifat kontekstual atau di luar individu, yaitu mencakup lingkungan individu baik sosial maupun fisik. Misalnya, pengalaman gejala dapat bervariasi menurut budaya karena ada komponen yang dipelajari untuk menafsirkan dan mengekspresikan gejala (Spector, 2000). Faktor situasional lain yang dapat mempengaruhi pengalaman gejala termasuk yang berhubungan dengan latar belakang pengalaman individu dan akses ke sumber daya, termasuk ketersediaan bantuan finansial, emosional, dan instrumental dalam menangani gejala tersebut.

Contohnya adalah status sosial ekonomi, status perkawinan dan keluarga, pekerjaan, tuntutan pekerjaan atau keluarga, akses dukungan sosial, akses perawatan kesehatan, dan kecukupan perawatan kesehatan dan dukungan yang diberikan. Dukungan sosial dapat dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi psikologis, jika dikonseptualisasikan dan diukur untuk mencerminkan persepsi individu tentang potensi ketersediaan dukungan, bukan sebagai faktor situasional yang mencerminkan tingkat dukungan yang benar-benar tersedia dan/atau diterima. Karakteristik pengaturan di mana individu menerima perawatan menjadi institusi (misalnya, kebijakan dan prosedur, tingkat kepegawaian) atau rumah (misalnya, peralatan yang tersedia, pengetahuan dan keterampilan pengasuh)—mungkin juga menjadi pertimbangan situasional yang penting. Lingkungan fisik dapat juga mempengaruhi gejala; meliputi ketinggian, suhu, kelembaban, tingkat kebisingan, cahaya, dan adanya polutan atau iritan di udara atau air.

3. Hasil kinerja

Konsep hasil dalam TOUS adalah kinerja yang mewakili konsekuensi dari pengalaman gejala. Secara sederhana, teori ini menegaskan bahwa pengalaman gejala dapat berdampak pada kemampuan individu secara fisik, kognitif, dan peran yang ditentukan oleh sosial. Peran kinerja adalah kemampuan untuk melakukan perawatan pribadi dan peran sosial, termasuk aktivitas kehidupan sehari-hari dan ekspektasi terkait pekerjaan. Kognitif kinerja adalah kemampuan untuk menjalankan

fungsi kognitif yang meliputi memori, pemahaman, pembelajaran, konsentrasi, dan pemecahan masalah.

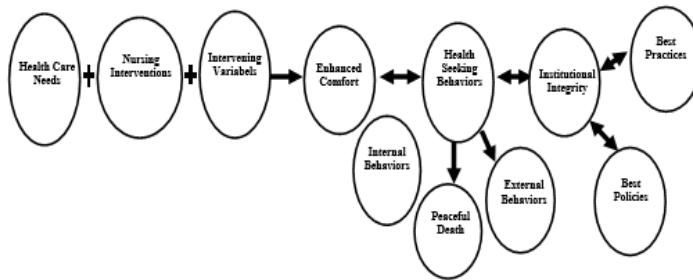
Gejala tertentu atau serangkaian gejala dapat menghasilkan sejumlah gejala yang berbeda hasil kinerja yang mungkin terjadi secara bersamaan tetapi juga dapat berupa waktu dipesan. Hasil kinerja yang proksimal dalam waktu untuk gejala pengalaman dapat mempengaruhi hasil yang lebih distal, terutama jika gejalanya dipertahankan untuk jangka waktu tertentu.

B. Theory of Comfort

Kenyamanan adalah keadaan sementara dan dinamis yang ditandai dengan kemudahan dari rasa sakit, tekanan emosional dan fisik dan munculnya rasa positif, keamanan, kekuatan, dan penerimaan situasi seseorang yang didukung dan ditopang oleh perasaan dihargai, diperhatikan, percaya diri dan menerima pengobatan dengan pilihan. Kenyamanan total sulit dipahami; sebaliknya, pasien berusaha nyaman mungkin dalam situasi interaksi kesehatan mereka (Wensley et al., 2020). Kebutuhan pasien akan perawatan yang menenangkan bervariasi antar individu dan dapat terjadi pada setiap tahap interaksi perawatan kesehatan. Pemicu umum adalah ketidakpastian dan ketakutan pengobatan dan prosedur yang direncanakan; sakit, emosional dan tekanan fisik; merasa rentan, tergantung dan lemah dari kehilangan fungsional dan efek akumulatif dari beberapa gejala; berada di lingkungan yang tidak dikenal dan rindu rumah dan keluarga.

Teori kenyamanan merupakan salah satu teori keperawatan tingkat sedang yang dikembangkan oleh Kolcaba (1994). Meskipun kenyamanan adalah konsep multifaset yang sulit untuk didefinisikan, itu adalah yang

diinginkan dan hasil yang dapat diterima yang ingin dicapai dengan asuhan keperawatan yang efektif. Mencapai dan mempertahankan kenyamanan pasien serta intervensi keperawatan terapeutik terletak di jantung keperawatan dan fungsi keperawatan. Kolcaba telah menentukan tingkat kenyamanan sebagai kelegaan, kemudahan dan transendensi sesuai dengan intensitas pemenuhan kebutuhan kenyamanan individu. Dia juga menjelaskan tingkat kenyamanan fisik, psiko-spiritual, lingkungan dan sosial budaya sesuai dengan sudut pandang holistik. Stres dan kecemasan diamati pada wanita kanker payudara stadium awal pasien, serta efek samping pengobatan, memiliki efek negatif pada kenyamanan mereka. Kecenderungan yang berkembang dari pasien dengan peningkatan kenyamanan, baik secara sadar atau tidak sadar, menuju perilaku mencari kesehatan, menimbulkan pembenaran untuk penerapan intervensi peningkatan kenyamanan. Penentuan terapi radiasi untuk kenyamanan, penerapan intervensi yang akan meningkatkan tingkat kenyamanan pasien dan pencapaian kontinuitasnya adalah salah satu tanggung jawab mendasar perawat (Pehlivan et al., 2016).



Gambar 3. 2 Kerangka Kerja Konseptual *Theory of Comfort*
(Copyright Kolcaba, 2007. Retrieved from Alligood, 2014)

1. Kebutuhan keperawatan Kesehatan

Menurut Kolcaba (2003) kebutuhan perawatan kesehatan adalah kebutuhan kenyamanan yang timbul dari situasi perawatan kesehatan yang penuh tekanan yang tidak dapat dipenuhi sistem dukungan tradisional penerima. Kebutuhannya mungkin fisik, psikospiritual, sosiokultural, atau lingkungan. Mereka menjadi jelas melalui pemantauan, laporan verbal atau nonverbal, parameter patofisiologis, pendidikan dan dukungan, dan keuangan konseling dan intervensi (Alligood, 2014).

2. Intervensi Kenyamanan

Intervensi kenyamanan adalah tindakan keperawatan dan rujukan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan khusus penerima, termasuk fisiologis, sosial, budaya, keuangan, psikologis, spiritual, lingkungan, dan intervensi fisik.

3. Variabel intervening

Variabel intervening adalah kekuatan yang saling berinteraksi mempengaruhi persepsi penerima tentang kenyamanan total. Mereka terdiri dari pengalaman masa lalu, usia, sikap, keadaan emosi, sistem pendukung,

prognosis, keuangan, pendidikan, latar belakang budaya, dan totalitas elemen dalam pengalaman penerima (Kolcaba, 1994). Variabel intervening tersebut berdampak pada perencanaan dan keberhasilan intervensi perawatan pasien.

4. Kenyamanan

Kenyamanan adalah keadaan yang dialami oleh penerima intervensi kenyamanan. Ini langsung, holistik pengalaman diperkuat saat seseorang membutuhkannya ditujukan untuk tiga jenis kenyamanan (kelegaan, kemudahan, dan transendensi) dalam empat konteks (fisik, psikospiritual, sosiokultural, dan lingkungan).

5. Perilaku mencari Kesehatan

Perilaku pencarian kesehatan mencakup kategori yang luas hasil yang terkait dengan pengejaran kesehatan sebagai ditentukan oleh penerima setelah berkonsultasi dengan perawat. Kategori tersebut disintesis oleh Schlotfeldt (1975) dan diusulkan menjadi internal, eksternal, atau kematian yang damai.

6. Integritas kelembagaan

Korporasi, komunitas, sekolah, rumah sakit, kawasan, negara bagian, dan negara yang memiliki kualitas menjadi lengkap, utuh, suara, tegak, menarik, beretika, dan tulus memiliki integritas kelembagaan. Ketika sebuah institusi menunjukkan tipe integritas ini, itu menghasilkan bukti untuk praktik terbaik dan kebijakan terbaik (Kolcaba, 2001).

7. Praktik terbaik

Penggunaan intervensi perawatan kesehatan berdasarkan bukti untuk menghasilkan pasien sebaik mungkin dan hasil keluarga (kelembagaan) dikenal sebagai yang terbaik praktek.

8. Kebijakan Terbaik

Kebijakan kelembagaan atau regional mulai dari protokol untuk prosedur dan kondisi medis hingga akses dan pemberian perawatan kesehatan dikenal sebagai yang terbaik kebijakan.

Nyeri merupakan salah satu kebutuhan yang diungkapkan pasien. Untuk menghilangkan rasa sakit, itu penting bahwa perawat memiliki waktu untuk mendengarkan keluhan pasien, membantu mereka dan menyadari tanda ketidaknyamanan nyeri. Factor yang mempengaruhi kenyamanan yaitu:

1. Strategi menenangkan diri

Berpikir positif, mencari (dan menemukan) tanda-tanda keamanan dan normalitas, rutinitas perawatan diri, mengembangkan penerimaan (mendapatkan informasi, perencanaan, belajar untuk percaya).

2. Terhubung secara budaya

Menemukan keakraban budaya, merasakan bahwa norma dan nilai budaya seseorang dipahami dan dihormati.

3. Terhubung secara spiritual

Mempertahankan praktik spiritual atau keagamaan yang signifikan secara pribadi.

4. Keluarga

Keluarga memiliki kemampuan unik untuk kenyamanan yang timbul dari budaya bersama dan pengertian.

5. Manajemen gejala

Semua gejala (bukan hanya nyeri).

6. Bantuan holistik

Intervensi nonfarmakologis untuk memudahkan ketidaknyamanan, bantuan yang diberikan dengan sukarela.

7. Staf yang terlibat dan berkomitmen

Kehadiran staf, penghiburan terapeutik strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

8. Informasi dan partisipasi

Informasi akurat yang sensitif disediakan sehingga pasien dapat mempersiapkan apa yang ada di depan. Peluang untuk berpartisipasi dalam, dan mempersonalisasi, peduli.

9. Staf yang kompeten

Dirasakan dan aktual

10. Fasilitas fisik dan suasana

Bersih, dilengkapi dengan baik dan ramah keluarga. Pasien dapat mengontrol ruang pribadi mereka (lampu, kebisingan). Proyek staf dan suasana positif dan kepedulian, terlihat bekerja sebagai tim yang kohesif dan punya waktu untuk semua kebutuhan pasien

Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori kolcaba yaitu (Alligood, 2014):

1. Setiap individu menunjukkan respons holistik terhadap stimulus kompleks yang diterima.
2. Kenyamanan adalah hasil holistik yang ingin dicapai oleh setiap individu dan erat kaitannya dengan disiplin keperawatan.
3. Kenyamanan adalah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh setiap individu. Hal ini merupakan usaha aktif.

4. Pencapaian kenyamanan seorang individu memberikan kekuatan bagi pasien dalam membentuk setiap kesadaran terkait kesehatan dirinya.
5. Pasien yang menunjukkan kesadaran terkait kesehatan dirinya yang tinggi cenderung memiliki kepuasan tersendiri dengan asuhan yang diperoleh.
6. Integritas, institusi didasari oleh orientasi siswa nilai penerima asuhan. Sama pentingnya orientasi terhadap promosi kesehatan, asuhan holistik dalam konteks keluarga dan pemberi asuhan.

Kolcaba menggunakan idenya dari 3 teori keperawatan sebelumnya untuk mensintesis atau mengidentifikasi jenis kenyamanan menurut analisis konsep. Ada 3 tingkat kenyamanan menurut kolcaba (Alligood, 2014):

1. Relief: Keadaan pasien yang memiliki kebutuhan khusus yang terpenuhi. Menurut pada arti kenyamanan dari hasil riset Orlando, yang mengemukakan bahwa perawat dapat meringankan kebutuhan pasien, termasuk pada kebutuhan kenyamanan yang spesifik
2. Ease: Keadaan tenang atau puas. Meningkatkan rasa nyaman atau terbebas dari rasa tidak nyaman. Merupakan definisi kenyamanan dari hasil riset Henderson, yang mendeskripsikan ada 14 fungsi dasar pada manusia yang seharusnya dipertahankan selama proses pemberian asuhan keperawatan.
3. Transendensi: Keadaan dimana seseorang mengatasi masalah atau rasa sakitnya yang dapat beradaptasi atau mampu mentoleransikan dirinya dengan ketidaknyamanan. Hal ini merupakan penjabaran dari hasil riset Paterson dan Zderat, yang menjelaskan pasien dibantu perawat dalam mengatasi kesulitannya.

Aspek kenyamanan menurut teori Kolcaba yaitu:

1. Fisik: Berkaitan dengan sensasi tubuh dan homeostasis, yang mencakup penurunan kemampuan tubuh di dalam merespon suatu penyakit atau prosedur invasif. Beberapa pilihan untuk memenuhi masalah kenyamanan ini adalah memberikan obat, merubah posisi, kompres hangat dingin, maupun sentuhan terapeutik.
2. Psikospiritual: Berkaitan dengan kesadaran internal diri, termasuk harga diri, konsep, seksualitas, dan makna dalam hidup seseorang; hubungan seseorang dengan tatanan atau makhluk yang lebih tinggi.
3. Sosialkultural: Kebutuhan kenyamanan sosiokultural berhubungan dengan hubungan interpersonal, keluarga dan masyarakat yang mencakup kebutuhan pada informasi pemulangan atau discharge planning dan perawatan yang disesuaikan dengan budaya yang dimiliki pasien. Kebutuhan ini dipenuhi melalui coaching atau pemberian pendidikan kesehatan (informasi), promosi, pelatihan, mendapat informasi perkembangan yang berhubungan dengan prosedur pulang dari rumah sakit dan rehabilitasi.
4. Lingkungan: Berkaitan dengan kerapian lingkungan, lingkungan yang sepi, perabotan yang nyaman, bau lingkungan minimum dan keamanan lingkungan. Tingkatan yang dapat dilakukan perawat meliputi mengurangi kebisingan, memberikan penerangan yang cukup, dan mengurangi gangguan pada saat tidur.

Kolcaba menggunakan tiga jenis logika berikut untuk penalaran dalam pengembangan *Theory of Comfort* (Alligood, 2014):

1. Induksi

Induksi terjadi ketika penyamarataan dibangun dari suatu kejadian yang diamati secara spesifik. Di mana perawat dengan sungguh-sungguh melakukan praktek dan dengan sungguh-sungguh menerapkan keperawatan sebagai disiplin, sehingga mereka menjadi terbiasa dengan konsep Implisit atau eksplisit, terminologi, dalil, dan asumsi pendukung praktek mereka. Ketika perawat lulus sekolah, mereka mungkin diminta untuk menjelaskan diagram prakteknya, yang mana tugas tersebut sangatlah mudah.

2. Deduksi

Deduksi adalah suatu format dari pemikiran logis di mana kesimpulan spesifik berasal dari prinsip atau pendapat yang lebih umum; prosesnya dari yang umum ke yang spesifik. Langkah mengurangi pengembangan teori mengakibatkan teori kenyamanan dapat dihubungkan dengan konsep lain untuk menghasilkan suatu teori. Kerja dari tiga ahli teori keperawatan diperlukan untuk mendefinisikan kenyamanan. Oleh karena itu Kolcaba lebih dulu melihat di tempat lain untuk bekerja secara bersama untuk menyatukan kebutuhan seperti keringanan, ketentraman dan hal yang penting. Apa yang dibutuhkan, dia merealisasikan suatu yang abstrak dan kerangka konseptual umum yang sama dengan kenyamanan dan berisi dalam jumlah banyak yang bersifat abstrak.

3. Retroduksi

Retroduksi adalah suatu format pemikiran untuk memulai ide. Bermanfaat untuk memilih suatu fenomena yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan diuji. Pemikiran jenis ini diterapkan di (dalam) bidang dimana tersedia sedikit teori. Seperti pada kasus hasil riset, dimana saat ini memusat pada pengumpulan database besar untuk mengukur hasil dan berhubungan pada pengeluaran untuk jenis keperawatan, medis, institusi, atau protokol masyarakat. Penambahan suatu kerangka teori keperawatan untuk riset hasil akan meningkatkan area penelitian keperawatan karena praktek dasar teori memungkinkan perawat untuk mendesain intervensi yang sama dan selaras dengan hasil yang diinginkan. (Hardin & Bishop, 2010).

BAB 4

MANAJEMEN NYERI

A. Definisi Nyeri

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan jaringan aktual maupun potensial yang mengalami kerusakan (HCANJ, 2017). Manajemen Nyeri merupakan penilaian nyeri dan pengobatan untuk terpenuhinya masalah nyeri. (HCANJ, 2017).

B. Karakteristik Nyeri

Karakteristik nyeri dan karakteristik pasien yang relevan dengan nyeri kanker biasanya digunakan dalam praktik klinis untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan nyeri dalam domain tertentu. Karakteristik nyeri seperti intensitas, durasi, kualitas, distres dan asal nyeri.

1. Intensitas nyeri

Intensitas adalah salah satu karakteristik nyeri yang paling relevan dan sebagai standar penilaian nyeri. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur intensitas seperti *Numerical Rating Scales* (NRS) dengan tiga kategori nyeri menurut tingkat keparahan nyeri yaitu ringan (NRS 1-4), sedang (5-6), dan berat (7-10). Namun, intensitas nyeri perlu menjadi bagian dari penilaian yang komprehensif dan harus selalu dipertimbangkan dalam karakteristik individu pasien termasuk usia, fungsi kognitif, dan aspek psikologis (Caraceni & Shkodra, 2019).

2. Durasi

Secara tradisional nyeri telah diklasifikasikan sebagai nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut merupakan nyeri normal yang biasanya datang secara tiba-tiba atau mendadak, dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Nyeri kronis didefinisikan sebagai keluhan nyeri yang berlangsung selama lebih dari 3 – 6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun setelah mengalami cedera atau gangguan tertentu. Kondisi ini umumnya memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Seseorang yang mengalami nyeri kronis ternyata lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan, dibanding dengan orang yang mengalami nyeri akut.

3. Kualitas

Domain pada deskriptor kualitas nyeri yaitu sensorik, afektif, evaluatif dan lain-lain. kualitas sensorik nyeri (misalnya, waktu/temporal, lokasi/spasial, suhu/thermal). kualitas afektif nyeri (misalnya stres, takut, sifat-sifat otonom).

4. Distres

Nyeri terkait Distres dinilai bersamaan dengan skala intensitas nyeri. Distres merupakan dampak dari keparahan nyeri.

5. Berdasarkan sumber nyeri

a. Nyeri nosiseptif

Nyeri nosiseptif biasanya berasal dari rangsangan nyeri reseptor yang timbul dari peradangan jaringan, deformasi mekanis, berkelanjutan cedera, atau kehancuran. Merespon dengan baik obat analgesik umum dan non-obat strategi. Nyeri nosiseptif dikategorikan menjadi dua jenis yaitu nyeri viseral dan nyeri somatik. Nyeri somatik adalah nyeri yang diakibatkan

aktivasi nosiseptor (reseptor sensorik) yang sensitif terhadap rangsangan berbahaya di kulit atau jaringan dalam. Berpengalaman secara lokal dan digambarkan sebagai konstan, sakit dan menggerogoti. Nyeri ini termasuk jenis yang paling umum pada pasien kanker. Nyeri Viseral adalah nyeri yang dimediasi oleh nosiseptor. Digambarkan sebagai nyeri yang terjadi pada bagian dalam tubuh dan menimbulkan rasa sakit dan kolik (Yam et al., 2018).

b. Nyeri neuropatik

Nyeri neuropatik biasanya digambarkan sebagai rasa terbakar, mati rasa, atau listrik, dan dapat hadir dengan manifestasi neurologis tambahan, seperti perubahan sensorik, kelemahan otot, atau disfungsi otonom (Jara et al., 2018). Melibatkan sistem saraf perifer atau pusat. Tidak merespon seperti yang diduga sebagai nyeri nosiseptif terhadap analgesik konvensional. Dapat menanggapi obat analgesik adjuvan (Yam et al., 2018).

c. Nyeri peradangan

Nyeri peradangan adalah respon biologis alami yang dihasilkan oleh jaringan di dalam tubuh kita sebagai reaksi terhadap rangsangan berbahaya untuk membasmi sel-sel nekrotik dan memulai proses perbaikan jaringan. Neutrofil biasanya merupakan responden pertama dari respon inflamasi dan berkumpul di lokasi cedera melalui aliran darah, diikuti dengan pelepasan mediator kimia lainnya. Peradangan dapat menyebabkan tiga respons utama: hiperalgesia, alodinia, dan nyeri yang dipertahankan simpatis (Yam et al., 2018).

C. Mekanisme Nyeri

Mekanisme nyeri pada dasar mengalami tiga peristiwa yaitu transduksi, transmisi, dan modulasi ketika ada rangsangan berbahaya.

1. Transduksi

Transduksi Proses ini terjadi di perifer ketika rangsangan berbahaya (nyeri) menyebabkan kerusakan jaringan (Doody & Bailey, 2019).

Transduksi terjadi sepanjang jalur nosiseptif mengikuti urutan seperti: peristiwa stimulus diubah menjadi jaringan kimia, jaringan kimia dan peristiwa celah sinaptik kemudian diubah menjadi peristiwa listrik di neuron dan peristiwa listrik di neuron di transduksi sebagai peristiwa kimia di sinapsis. Transduksi adalah bagian tak terpisahkan dari proses untuk mendeteksi rangsangan eksternal: tanpa transduksi, tubuh manusia akan kehilangan kemampuan untuk merasakan, menyentuh, mendengar, melihat, atau merasakan sakit. Transduksi terjadi ketika, sebagai respons terhadap stimulus fisik, proses somatosensori memfasilitasi pembukaan saluran gerbang ion dan mengubah stimulus fisik menjadi sinyal elektrokimia yang dapat dikirim ke dan dirasakan oleh pusat saraf tingkat tinggi (Yam et al., 2018). Impuls saraf bergerak dari perifer ke kornu dorsalis sumsum tulang belakang dan kemudian naik ke pusat yang lebih tinggi di otak (Doody & Bailey, 2019).

2. Transmisi

Setelah transduksi selesai, mekanisme berikut adalah transmisi. Mekanisme ini mentransmisikan peristiwa listrik di sepanjang jalur saraf, sementara neurotransmitter dicelah sinaptik mengirimkan informasi

dari terminal pasca-sinaptik satu sel ke terminal pra-sinaptik dari yang lain (Yam et al., 2018).

3. Modulasi

Sementara itu, peristiwa modulasi terjadi di semua tingkat jalur nosiseptif melalui neuron aferen primer, DH dan pusat otak yang lebih tinggi dengan regulasi naik atau turun. Semua ini mengarah ke satu hasil akhir, dan jalur rasa sakit telah dimulai dan diselesaikan, sehingga memungkinkan kita untuk merasakan sensasi nyeri yang dipicu oleh stimulus (Yam et al., 2018). Melalui intervensi farmakologis dan non-farmakologis, persepsi

Nyerinya akan berubah. Neuron yang berasal dari batang otak turun ke sumsum tulang belakang dan melepaskan zat yang dapat menghambat transmisi impuls berbahaya (menyakitkan) (Doody & Bailey, 2019).

D. Tahapan Nyeri

Persepsi dari serangkaian peristiwa sensorik diperlukan untuk otak untuk mendeteksi rasa sakit dan menghasilkan respons terhadap ancaman. Umumnya ada tiga tahapan dalam persepsi nyeri (Yam et al., 2018).

1. Tahap pertama

Tahap ini merupakan kepekaan rasa sakit.

2. Tahap kedua

Tahap selanjutnya yaitu dimana sinyal ditransmisikan dari perifer ke *dorsal horn*, yang terletak di tulang belakang melalui sistem saraf perifer.

3. Tahap ketiga

Setelah melakukan transmisi sinyal ke otak yang lebih tinggi melalui sistem saraf pusat. Biasanya, ada dua rute untuk transmisi sinyal yang akan dilakukan: jalur naik dan turun. Jalur menaik merupakan jalan yang dilalui ke atas

membawa informasi sensorik dari tubuh melalui sumsum tulang belakang menuju otak, sedangkan saraf yang turun dari otak ke organ refleks melalui sumsum tulang belakang dikenal sebagai jalur turun.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri

Berikut adalah factor-faktor yang mempengaruhi nyeri:

1. Faktor fisiologis

a. Usia

Semakin bertambahnya usia mengalami penurunan ambang nyeri (Cámara et al., 2020).

b. Jenis kelamin

Perempuan mengalami rasa nyeri lebih intens daripada laki-laki, hal ini menunjukkan ambang nyeri perempuan lebih rendah dibanding pada laki-laki (Cámara et al., 2020).

c. Lama diagnosa penyakit

2. Faktor psikologis

Faktor psikologis yang terlibat dalam pengalaman nyeri dapat dikelompokkan mulai dari kesadaran nyeri (yaitu, perhatian), kemudian dengan evaluasi nyeri (yaitu, *Catastrophizing*) yang mengarah ke perasaan (yaitu, faktor emosional seperti kecemasan dan depresi) dan perilaku tentang rasa sakit (yaitu, koping strategi) (Ciucă & Băban, 2017).

a. Perhatian

Salah satu tujuan dari rasa sakit adalah untuk menuntut perhatian. Nyeri adalah sinyal peringatan dan gangguan, perhatian ini sangat membantu dan adaptif untuk kelangsungan hidup. Inilah alasan mengapa mengabaikan rasa sakit adalah sulit. Memfokuskan

perhatian jauh dari rasa sakit dapat menyebabkan penurunan intensitas nyeri (Ciucă & Băban, 2017).

b. Catastrophizing

Setelah perhatian difokuskan pada rasa nyeri, Nyeri kronis mempengaruhi fungsi otak dari tingkat molekuler ke sistem terkemuka untuk gangguan di daerah otak penting untuk fungsi kognitif. *Negative interpretation*, rasa nyeri dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam rasa sakit dialami pasien nyeri kronis. *Beliefs and attitudes* dapat berdampak pada pengalaman dan pengobatan nyeri. Sikap nyeri memainkan peran sentral dalam perilaku nyeri. Sikap negatif mengenai nyeri telah dikaitkan dengan fungsi psikologis yang buruk dan tingkat aktivitas fisik. Keyakinan umum adalah obat yang efektif untuk nyeri dan ini memoderasi hubungan antara keparahan nyeri dan perilaku nyeri. *Expectations*, mengenai intensitas, kualitas dan durasi nyeri mempengaruhi persepsi subjektif nyeri. Aspek penting dari harapan adalah apakah mereka terpenuhi atau tidak. Harapan yang tak terpenuhi dapat menyebabkan kognisi negatif dan harapan yang terpenuhi dapat mengarah pada penguatan. Mengingat ini, harapan yang akurat mengenai mengalami rasa sakit, manajemen, dan pemulihan dapat memiliki dampak positif pada persepsi nyeri. *Pain catastrophizing*, ditandai dengan kecenderungan orientasi negatif yang berlebihan terhadap kemungkinan atau rasa sakit yang sebenarnya. Pikiran bencana biasanya dinyatakan sebagai pikiran tidak berdaya. Nyeri katastrofi adalah terkait dengan intensitas nyeri, tekanan emosional,

penggunaan obat nyeri, kecacatan, fungsi fisik dan psikososial yang lebih rendah (Ciucă & Băban, 2017).

c. Faktor emosional

Nyeri memiliki dampak penting pada emosi pasien. Reaksi emosional terhadap rasa sakit biasanya meliputi kecemasan, ketakutan, kemarahan, rasa bersalah, frustrasi dan depresi. Kecemasan dan depresi sering dilaporkan pada pasien dengan kanker stadium lanjut. Kecemasan adalah prediktor untuk dimensi sensorik dari pengalaman nyeri dan dapat dikaitkan dengan tingkat nyeri. Kecemasan juga merupakan gejala jangka panjang pada penderita kanker dan berdampak pada kualitas hidup. Depresi adalah prediktor dari dimensi afektif dari pengalaman nyeri. Depresi lebih sering terjadi pada pasien dengan peningkatan keparahan dan intensitas nyeri. Semakin lama nyeri yang dialami semakin tinggi risiko untuk depresi (Ciucă & Băban, 2017).

d. Strategi koping

Strategi koping nyeri atau keterampilan koping adalah kognitif (mis., Memfokuskan diri dari rasa sakit) atau teknik perilaku (misalnya, relaksasi otot). diaktifkan untuk mengurangi rasa sakit. Strategi koping bisa adaptif (misalnya, terlibat dalam kegiatan menghibur) atau maladaptif (misalnya, perilaku menyakiti diri sendiri). Strategi koping dipelajari dan dikembangkan dari interaksi kognitif, emosional dan perilaku sistem (Ciucă & Băban, 2017).

3. Faktor situasional

a. Dukungan keluarga

Dukungan sosial dapat meningkatkan respons koping adaptif, hal ini dapat meningkatkan penyesuaian

pasien terhadap nyeri kronis. Dengan dukungan keluarga, pasien lebih bisa menerima dan bisa berdamai dengan nyeri yang dirasakan. Pasien dengan suasana hati yang lebih baik dan mekanisme koping yang lebih baik mampu membuat langkah positif dalam pengobatan (Riquelme et al., 2021).

b. Caring perawat

Caring merupakan suatu perilaku atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan asuhan secara fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan pasien secara tulus (Kusnanto, 2019).

c. Kepuasan pelayanan

Kepuasan pelayanan dapat mempengaruhi persepsi nyeri.

F. Definisi Manajemen Nyeri

Manajemen Nyeri merupakan penilaian nyeri dan pengobatan untuk terpenuhinya masalah nyeri (HCANJ, 2017). Penatalaksanaan nyeri nonfarmakologi adalah penatalaksanaan nyeri tanpa obat. Metode ini menggunakan cara untuk mengubah pikiran dan memusatkan konsentrasi untuk mengelola dan mengurangi rasa nyeri menjadi lebih baik.

G. Manajemen Nyeri Fisik

Intervensi fisik tidak terbatas pada latihan terapi atau pengkondisian, terapi fisik seperti okupasi, pijat, penggunaan panas dan atau dingin, akupunktur, dan akupresur (Swarm et al., 2019).

1. *Exercise*

Yoga: dapat meningkatkan kekuatan dan mengurangi

stres.

2. Aplikasi panas/dingin: dapat membanuradang sendi dan juga bisa menggunakan panas dingin untuk nyeri otot dan nyeri lainnya.
3. Terapi pijat: dapat mengurangi ketegangan otot.
4. Meditasi: dapat membantu memusatkan pikiran pada sesuatu selain rasa nyeri. Itu juga bisa mengurangi stres.
5. Terapi musik, seni atau drama
6. Penentuan posisi nyaman
7. Terapi fisik dan okupasi: perawatan ini dapat meningkatkan kebugaran secara keseluruhan.

Terapi fisik dan okupasi melibatkan hal-hal berikut:

1. *Aquatherapy*
2. *Tone and strengthenig*
3. *Desensitization*

Neuro stimulasi melibatkan hal-hal berikut ini:

1. Stimulasi saraf listrik transkutan (TENS): arus listrik ringan digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.
2. Akupunktur: jarum yang sangat tipis ditusukkan ke kulit ditempat-tempat tertentu tubuh untuk menghilangkan rasa sakit. Sistem perawatan medis dan ideologi berdasarkan prinsip penerapan jarumkecil atau tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh.
3. Akupresur: praktik menerapkan tekanan jari lembutke titik-titik yang terletak disepanjang meridian energi tubuh yang digunakan dalam pengobatan tradisional cina. Setiap titik memberikan efek psikologis, neurologis, imunologi tetentu untuk menyeimbangkan fungsi fisiologis dan psikologis yang optimal.

H. Manajemn Nyeri Psikologis

Intervensi psikososial secara khusus menangani perasaan, pikiran, dan perilaku. Intervensi psikososial memiliki efek menguntungkan padakualitas hidup dan hasil kesehatan psikologis lainnya pada pasien kanker di semua tahap penyakit (Warth et al., 2020).

Nyeri kronis dapat memiliki efek psikologis yang mendalam, termasuk marah, sedih dan bahkan putus asa. Perasaan ini dapat mengganggu kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas normal sehari-hari.

Terapi psikologis dapat membantu mengatasi nyeri yang muncul dari efek penyakit atau suatu rangkaian pengobatan. Terapi psikologis dapat membantu mengurangi tekanan emosional yang terkait dengan nyeri kronis. Dengan mempelajari teknik-teknik ini, rasa nyeri dapat diubah dan penderitaan semakin berkurang. Berikut adalah teknik psikologis khusus yang dapat membantu mengurangi nyeri:

1. Teknik psikofisiologis

Biofeedback dan teknik relaksasi mengajarkan bagaimana cara melepaskan ketegangan dan kecemasan yang sering kali membuat kondisi fisik yang menyakitkan menjadi lebih menyiksa. *Biofeedback* dapat digunakan untuk membantu mengontrol ketegangan otot, detak jantung, dan reaksi lain terhadap rasa sakit.

2. Terapi kognitif

Self-hypnosis dan *visual imagery* merupakan teknik yang membantu untuk mengendalikan rasa nyeri yang mengganggu pola tidur. Hipnosis dapat membantu memusatkan pikiran padasesuatu selain nyeri.

Metode hipnosis meliputi:

a. *Imagery*

- b. Distraksi
 - c. Relaksasi
3. Konseling individu dan kelompok
- Terapi konseling psikososial melibatkan hal-hal berikut ini:
- a. Konseling individu
 - b. Konseling keluarga
 - c. Konsling kelompok

I. Manajemen Nyeri Spiritual

Keyakinan spiritual dan agama penting dalam kehidupan. Namun, agama dan spiritualitas tidaklah sama. Keyakinan ini dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap dan perasaan tentang kehidupan, rasa sakit dan kematian. Keyakinan spiritual dan agama membantu beberapa orang dalam menerima keadaan penyakit. Keyakinan spiritual sering membantu orang merencanakan masa depan. Agama dapat membantu orang menjalani kehidupan yang lebih mendalam serta memperkuat atau menghibur orang selama sakit dan dalam persiapan menghadapi kematian.

Dalam perawatan kanker, ada minat yang tumbuh dalam perhatian pada kebutuhan spiritual dan kekhawatiran eksistensial sering dikaitkan dengan rasa sakit. Banyak pasien memegang keyakinan budaya tentang perawatan tersebut, dan pengobatan rumah, ritual, doa, dan praktik spiritual lainnya mungkin sangat membantu dalam menghilangkan atau mengatasi rasa sakit. Keterlibatan spiritual penyedia perawatan dari berbagai budaya yang sesuai latar belakang spiritual sangat penting (Swarm et al., 2019).

Strategi berbasis spiritualitas biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri kronis. Pasien kanker dengan nyeri

dapat mempratekan sejumlah intervensi agama dan spiritual seperti berdoa, mencari dukungan spiritual untuk mengatasi nyeri mereka.

BAB 5

PENUTUP

Kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak di dunia setelah kanker paru-paru. Sebagian besar pasien yang didiagnosis dengan kanker payudara akan mengalami efek dari rangkaian pengobatan atau disebabkan oleh proses penyakit itu sendiri. Salah satu gejala yang paling umum dialami yaitu nyeri. Nyeri kanker melibatkan komponen fisik, sosial, psikologis dan spiritual yang biasa disebut dengan nyeri yang bersifat multidimensi. Nyeri yang tidak dikelola dengan baik dan tidak berangsur berkurang dapat berdampak pada fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kontribusi masing-masing komponen bervariasi berdasarkan faktor individu dan keadaan yang dihadapi pasien. Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kenyamanan merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan yang dapat dicapai melalui perawatan yang berpusat pada pasien. Selain itu, kenyamanan adalah konsep holistik yang perlu diimplementasikan oleh tim keperawatan multidisiplin. Pengendalian nyeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara. Manajemen nyeri non farmakologis dalam kenyataannya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi perawat, hal ini berkaitan dengan perbedaan persepsi nyeri yang dialami oleh pasien. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengembangkan model manajemen nyeri berbasis *theory of unpleasant symptoms* dan *theory of comfort* terhadap kenyamanan pada pasien kanker payudara.

Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaknyamanan. Pengendalian nyeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara. Penanganan gejala-gejala yang muncul akibat kanker juga membutuhkan penanganan pada semua perubahan untuk menggunakan penerapan teori keperawatan. Teori keperawatan yang dapat diaplikasikan pada klien kanker payudara untuk menyelesaikan keluhan fisik, psikologis dan situasionalnya adalah *Theory of unpleasant symphoms*. Teori comfort dapat diaplikasikan terutama pada pasien yang mengalami nyeri dan pasien dengan peningkatan skala nyeri yang dipengaruhi kecemasan. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sesuatu yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi variasi gejala nyeri ada 3 faktor yaitu faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor situasional. Faktor fisiologis terdiri dari usia, jenis kelamin, dan lama diagnosa penyakit. Faktor psikologis terdiri dari perhatian, *catastrophizing*, ansietas, depresi, dan strategi koping. Faktor situasional terdiri dari dukungan keluarga, caring perawat, dan kepuasan pelayanan. Komponen variasi gejala nyeri terdiri dari timing, intensitas, kualitas dan distres. Selain itu faktor fisiologis, faktor psikologis dan situasional secara langsung maupun langsung dapat mempengaruhi manajemen nyeri. Manajemen nyeri berdasarkan kerangka teori ada 3 yaitu manajemen nyeri fisik, manajemen nyeri psikologis, manajemen nyeri spiritual. Manajemen nyeri dapat mempengaruhi kenyamanan setiap individu. Komponen kenyamanan ada 4 yaitu kenyamanan fisik, kenyamanan psikospiritual, kenyamanan, sosiokultural, kenyamanan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahrezi, A. (2017). Towards effective pain management: Breaking the barriers. *Oman Medical Journal*, 32(5), 357–358. <https://doi.org/10.5001/omj.2017.69>
- Alhazmi, L. S. S., Bawadood, M. A. A., Aljohani, A. M. S., Alzahrani, A. A. R., Moshref, L., Trabulsi, N., & Moshref, R. (2021). Pain Management in Breast Cancer Patients: A Multidisciplinary Approach. *Cureus*, 13(6), e15994. <https://doi.org/10.7759/cureus.15994>
- Alligood, M. R. (2014). Nursing Theorists and Their Work (8th edn). In *The CV Mosby Company St. Louis* (pp. 657–671). Missouri: Mosby Elsevier. Inc. <https://doi.org/10.5172/conu.2007.24.1.106a>
- Costa, W. A., Monteiro, M. N., Queiroz, J. F., & Gonçalves, A. K. (2017). Pain and quality of life in breast cancer patients. *Clinics (Sao Paulo, Brazil)*, 72(12), 758–763. [https://doi.org/10.6061/clinics/2017\(12\)07](https://doi.org/10.6061/clinics/2017(12)07)
- Lenz, E. R. (2018). Application of the Theory of Unpleasant Symptoms in Practice: A Challenge for Nursing. *Investigación En Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 20(1). <https://doi.org/10.11144/javeriana.ie20-1.atu5>
- Liehr, P. R., & Smith, M. J. (2014). Understanding middle range theory by moving up and down the ladder of abstraction. In M. J. Smith & P. R. Liehr (Eds.), *Middle Range Theory for Nursing*, Fourth Edition (thrid). springer publishing company. <https://doi.org/10.1891/9780826159922.0002>

- Mikšić, Š., Bošnjaković, M., Simić, I., Stanić, B., Stanković, M., & Stojkov, Ž. (2018). Theory of Unpleasant Symptoms and Concept of Nursing Support. *Southeastern European Medical Journal: SEEMEDJ*, 2(2), 17–22.
- Potter, P. ., & Perry, A. . (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Edisi.7*. Jakarta: Salemba Medika.
- Risdawati. (2020). Terapi Berbasis Spiritualitas Dalam Penanganan Nyeri Pasien Kanker Payudara: A Literature Review.
- Warth, M., Zöller, J., Köhler, F., Aguilar-Raab, C., Kessler, J., & Ditzen, B. (2020). Psychosocial Interventions for Pain Management in Advanced Cancer Patients: a Systematic Review and Meta-analysis. *Current Oncology Reports*, 22(1), 3. <https://doi.org/10.1007/s11912-020-0870-7>
- Alligood, M. R. (2014). *Nursing Theorists and Their Work* (8th edn). In The CV Mosby Company St. Louis (pp. 657–671). Missouri: Mosby Elsevier. Inc. <https://doi.org/10.5172/conu.2007.24.1.106a>
- Lenz, E. R. (2018). Application of the Theory of Unpleasant Symptoms in Practice: A Challenge for Nursing. *Investigación En Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 20(1). <https://doi.org/10.11144/javeriana.ie20-1.atus>
- Liehr, P. R., & Smith, M. J. (2014). Understanding middle range theory by moving up and down the ladder of abstraction. In M. J. Smith & P. R. Liehr (Eds.), *Middle Range Theory for Nursing, Fourth Edition* (thrid). springer publishing company.

<https://doi.org/10.1891/9780826159922.0002>

- Pehlivan, S., Kuzhan, A., Yildirim, Y., & Fadiloglu, C. (2016). Comfort and quality of life in patients with breast cancer undergoing radiation therapy. *Journal of B.U.ON.*, 21(3), 549–555.
- Wensley, C., Botti, M., McKillop, A., & Merry, A. F. (2020). Maximising comfort: How do patients describe the care that matters? A two-stage qualitative descriptive study to develop a quality improvement framework for comfort-related care in inpatient settings. *BMJ Open*, 10(5). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033336>
- Cámara, R. J. A., Gharbo, R. K., & Egloff, N. (2020). Age and Gender as Factors of Pressure Sensitivity of Pain-Free Persons: Are They Meaningful? *Journal of Pain Research*, 13, 1849–1859. <https://doi.org/10.2147/JPR.S248664>
- Caraceni, A., & Shkodra, M. (2019). Cancer Pain Assessment and Classification. *Cancers*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/cancers11040510>
- Ciucă, A., & Băban, A. (2017). Psychological factors and psychosocial interventions for cancer related pain. *Romanian Journal of Internal Medicine = Revue Roumaine de Medecine Interne*, 55(2), 63–68. <https://doi.org/10.1515/rjim-2017-0010>
- Doody, O., & Bailey, M. E. (2019). Understanding pain physiology and its application to person with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disabilities*, 23(1), 5–18. <https://doi.org/10.1177/1744629517708680>

- HCANJ. (2017). Pain Management Guideline. Health Care Association of NJ, 1–30. https://www.hcanj.org/files/2013/09/Pain-Management-Guidelines-_HCANJ-May-12-final.pdf
- Jara, C., del Barco, S., Grávalos, C., Hoyos, S., Hernández, B., Muñoz, M., Quintanar, T., Meana, J. A., Rodriguez, C., & de las Peñas, R. (2018). SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). *Clinical and Translational Oncology*, 20(1), 97–107. <https://doi.org/10.1007/s12094-017-1791-2>
- Kusnanto. (2019). *Perilaku Caring Perawat Profesional*. Surabaya: Fakultas keperawatan universitas airangga.
- Lenz, E. R. (2018). Application of the Theory of Unpleasant Symptoms in Practice: A Challenge for Nursing. *Investigación En Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 20(1). <https://doi.org/10.11144/javeriana.ie20-1.atus>
- Riquelme, I., Escobio-Prieto, I., Oliva-Pascual-Vaca, Á., Heredia-Rizo, A. M., & Montoya, P. (2021). Effect of Social Support in Pain Sensitivity in Children with Cerebral Palsy and Typically Developing Children. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094661>
- Swarm, R. A., Paice, J. A., Anghelescu, D. L., Are, M., Bruce, J. Y., Buga, S., Chwistek, M., Cleeland, C., Craig, D., Gafford, E., Greenlee, H., Hansen, E., Kamal, A. H., Kamdar, M. M., LeGrand, S., Mackey, S., Rachel McDowell, M., Moryl, N., Nabell, L. M., ... Gurski, L. A. (2019). Adult cancer pain, version 3.2019. *JNCCN*

- Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 17(8), 977–1007.
<https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.0038>
- Warth, M., Zöller, J., Köhler, F., Aguilar-Raab, C., Kessler, J., & Ditzen, B. (2020). Psychosocial Interventions for Pain Management in Advanced Cancer Patients: a Systematic Review and Meta-analysis. *Current Oncology Reports*, 22(1), 3.
<https://doi.org/10.1007/s11912-020-0870-7>
- Yam, M. F., Chun, Y., Id, L., & Tan, C. S. (2018). General Pathways of Pain Sensation and the Major Neurotransmitters Involved in Pain Regulation.
<https://doi.org/10.3390/ijms19082164>
- Al-Mahrezi, A. (2017). Towards effective pain management: Breaking the barriers. *Oman Medical Journal*, 32(5), 357–358. <https://doi.org/10.5001/omj.2017.69>
- Alhazmi, L. S. S., Bawadood, M. A. A., Aljohani, A. M. S., Alzahrani, A. A. R., Moshref, L., Trabulsi, N., & Moshref, R. (2021). Pain Management in Breast Cancer Patients: A Multidisciplinary Approach. *Cureus*, 13(6), e15994.
<https://doi.org/10.7759/cureus.15994>
- Alkabban, F., & Ferguson, T. (2021). *Breast Cancer*. StatPearls (Internet).
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482286/>
- Alligood, M. R. (2014). Nursing Theorists and Their Work (8th edn). In *The CV Mosby Company St. Louis* (pp. 657–671). Missouri: Mosby Elsevier. Inc.
<https://doi.org/10.5172/conu.2007.24.1.106a>
- Cámara, R. J. A., Gharbo, R. K., & Egloff, N. (2020). Age and

Gender as Factors of Pressure Sensitivity of Pain-Free Persons: Are They Meaningful? *Journal of Pain Research*, 13, 1849–1859.
<https://doi.org/10.2147/JPR.S248664>

Caraceni, A., & Shkodra, M. (2019). Cancer Pain Assessment and Classification. *Cancers*, 11(4).
<https://doi.org/10.3390/cancers11040510>

Ciucă, A., & Băban, A. (2017). Psychological factors and psychosocial interventions for cancer related pain. *Romanian Journal of Internal Medicine = Revue Roumaine de Medecine Interne*, 55(2), 63–68.
<https://doi.org/10.1515/rjim-2017-0010>

Costa, W. A., Monteiro, M. N., Queiroz, J. F., & Gonçalves, A. K. (2017). Pain and quality of life in breast cancer patients. *Clinics (Sao Paulo, Brazil)*, 72(12), 758–763.
[https://doi.org/10.6061/clinics/2017\(12\)07](https://doi.org/10.6061/clinics/2017(12)07)

Doody, O., & Bailey, M. E. (2019). Understanding pain physiology and its application to person with intellectual disability. *Journal of Intellectual Disabilities*, 23(1), 5–18. <https://doi.org/10.1177/1744629517708680>

Golemis, E. A., Scheet, P., Beck, T. N., Scolnick, E. M., Hunter, D. J., Hawk, E., & Hopkins, N. (2018). Molecular mechanisms of the preventable causes of cancer in the United States. *Genes & Development*, 32(13–14), 868–902.
<https://doi.org/10.1101/gad.314849.118>

Harbeck, N., Penault-Llorca, F., Cortes, J., Gnant, M., Houssami, N., Poortmans, P., Ruddy, K., Tsang, J., & Cardoso, F. (2019). Breast cancer. In *Nature Reviews Disease*

Primers (Vol. 5, Issue 1).
<https://doi.org/10.1038/s41572-019-0111-2>

HCANJ. (2017). Pain Management Guideline. *Health Care Association of NJ*, 1–30.
https://www.hcanj.org/files/2013/09/Pain-Management-Guidelines-_HCANJ-May-12-final.pdf

Jara, C., del Barco, S., Grávalos, C., Hoyos, S., Hernández, B., Muñoz, M., Quintanar, T., Meana, J. A., Rodriguez, C., & de las Peñas, R. (2018). SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017). *Clinical and Translational Oncology*, 20(1), 97–107.
<https://doi.org/10.1007/s12094-017-1791-2>

Koo, M. M., von Wagner, C., Abel, G. A., McPhail, S., Rubin, G. P., & Lyratzopoulos, G. (2017). Typical and atypical presenting symptoms of breast cancer and their associations with diagnostic intervals: Evidence from a national audit of cancer diagnosis. *Cancer Epidemiology*, 48, 140–146.
<https://doi.org/10.1016/j.canep.2017.04.010>

Kusnanto. (2019). *Perilaku Caring Perawat Profesional*. Surabaya: Fakultas keperawatan universitas airlangga.

Lenz, E. R. (2018). Application of the Theory of Unpleasant Symptoms in Practice: A Challenge for Nursing. *Investigación En Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 20(1). <https://doi.org/10.11144/javeriana.ie20-1.atu>

Liehr, P. R., & Smith, M. J. (2014). Understanding middle range theory by moving up and down the ladder of abstraction. In M. J. Smith & P. R. Liehr (Eds.), *Middle*

Range Theory for Nursing, Fourth Edition (third).
springer publishing company.
<https://doi.org/10.1891/9780826159922.0002>

- Mikšić, Š., Bošnjaković, M., Simić, I., Stanić, B., Stanković, M., & Stojkov, Ž. (2018). Theory of Unpleasant Symptoms and Concept of Nursing Support. *Southeastern European Medical Journal: SEEMEDJ*, 2(2), 17–22.
- Momenimovahed, Z., & Salehiniya, H. (2019). Epidemiological characteristics of and risk factors for breast cancer in the world. *Breast Cancer: Targets and Therapy*, 11, 151–164. <https://doi.org/10.2147/BCTT.S176070>
- Moo, T., Sanford, R., Dang, C., Morrow, M., Sloan, M., Cancer, K., Service, M., Sloan, M., Cancer, K., Service, M., Sloan, M., Cancer, K., Sloan, M., & Cancer, K. (2018). Overview of Breast Cancer Therapy. *HHS Public Access*, 13(3), 339–354. <https://doi.org/10.1016/j.cpet.2018.02.006> Overvie
w
- Pehlivan, S., Kuzhan, A., Yildirim, Y., & Fadiloglu, C. (2016). Comfort and quality of life in patients with breast cancer undergoing radiation therapy. *Journal of B.U.ON.*, 21(3), 549–555.
- Potter, P. ., & Perry, A. . (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Edisi.7*. Jakarta: Salemba Medika.
- Riquelme, I., Escobio-Prieto, I., Oliva-Pascual-Vaca, Á., Heredia-Rizo, A. M., & Montoya, P. (2021). Effect of Social Support in Pain Sensitivity in Children with Cerebral Palsy and Typically Developing Children. *International Journal of Environmental Research and*

Public Health, 18(9).
<https://doi.org/10.3390/ijerph18094661>

- Risdawati. (2020). *Terapi Berbasis Spiritualitas Dalam Penanganan Nyeri Pasien Kanker Payudara: A Literature Review*.
- Rosen, R. D., & Sapra, A. (2022). *TNM Classification*.
- Sauter, E. R. (2018). *Breast Cancer Prevention: Current Approaches and Future Directions*. 4, 64–71.
<https://doi.org/10.5152/ejbh.2018.3978>
- Sun, Y. S., Zhao, Z., Yang, Z. N., Xu, F., Lu, H. J., Zhu, Z. Y., Shi, W., Jiang, J., Yao, P. P., & Zhu, H. P. (2017). Risk factors and preventions of breast cancer. *International Journal of Biological Sciences*, 13(11), 1387–1397.
<https://doi.org/10.7150/ijbs.21635>
- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249. <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
- Swarm, R. A., Paice, J. A., Anghelescu, D. L., Are, M., Bruce, J. Y., Buga, S., Chwistek, M., Cleeland, C., Craig, D., Gafford, E., Greenlee, H., Hansen, E., Kamal, A. H., Kamdar, M. M., LeGrand, S., Mackey, S., Rachel McDowell, M., Moryl, N., Nabell, L. M., ... Gurski, L. A. (2019). Adult cancer pain, version 3.2019. *JNCCN Journal of the National Comprehensive Cancer Network*, 17(8), 977–1007.
<https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.0038>

- Tan, P. H., Ellis, I., Allison, K., Brogi, E., Fox, S. B., Lakhani, S., Lazar, A. J., Morris, E. A., Sahin, A., Salgado, R., Sapino, A., Sasano, H., Schnitt, S., Sotiriou, C., van Diest, P., White, V. A., Lokuhetty, D., & Cree, I. A. (2020). The 2019 World Health Organization classification of tumours of the breast. *Histopathology*, 77(2), 181–185. <https://doi.org/10.1111/his.14091>
- Warth, M., Zöller, J., Köhler, F., Aguilar-Raab, C., Kessler, J., & Ditzen, B. (2020). Psychosocial Interventions for Pain Management in Advanced Cancer Patients: a Systematic Review and Meta-analysis. *Current Oncology Reports*, 22(1), 3. <https://doi.org/10.1007/s11912-020-0870-7>
- Wensley, C., Botti, M., McKillop, A., & Merry, A. F. (2020). Maximising comfort: How do patients describe the care that matters? A two-stage qualitative descriptive study to develop a quality improvement framework for comfort-related care in inpatient settings. *BMJ Open*, 10(5). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033336>
- Yam, M. F., Chun, Y., Id, L., & Tan, C. S. (2018). *General Pathways of Pain Sensation and the Major Neurotransmitters Involved in Pain Regulation*. <https://doi.org/10.3390/ijms19082164>

GLOSARIUM

A

Asites adalah pembengkakan yang terjadi pada organ dalam perut akibat penumpukan cairan yang sering kali berhubungan dengan suatu penyakit.

B

Biopsikososial adalah cara pandang atau cara berfikir yang mempertimbangkan dari factor biologis, psikologis dan social dalam memahami Kesehatan, penyakit maupun perawatan dalam Kesehatan.

C

Cytotoxicity atau biasa disebut sitotoksitas merupakan Tingkat kerusakan pada sel-sel manusia yang diakibatkan oleh suatu zat tertentu.

Cluster atau klaster merupakan suatu kelompok yang sama atau serupa.

D

DNA adalah singkatan dari Deoxyribonucleic Acid merupakan molekul yang menyimpan informasi terkait genetic makhluk hidup.

E

Eksplisit adalah suatu Tindakan, perbuatan dan kata yang diutarakan secara gamblang terus terang, tersurat, tegas dan tidak berbelit-belit.

Estrogen adalah hormon Wanita yang mengatur siklus menstruasi dan menunjang kehamilan.

Eksistensial berasal dari kata eksistensi yang artinya keberadaan, tenar dan dikenal.

Exercise merupakan latihan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang baik.

F

FDA adalah singkatan dari food and drug administration merupakan badan pengawas makanan dan obat di Amerika Serikat.

G

Genetik adalah informasi sel makhluk hidup yang dapat diwariskan dan diturunkan kepada keturunannya.

Generik merupakan suatu yang umum dan berkaitan dengan barang atau obat yang dijual secara bebas.

H

Holistik adalah cara pandang seseorang secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian.

Histologis adalah suatu bidang ilmu biologi yang membahas atau mempelajari struktur fungsi dan kondisi penyakit jaringan.

I

Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu.

Implementasi adalah pelaksanaan kegiatan dari sesuatu yang sudah direncanakan.

Interpretasi adalah memberikan penjelasan atau menerjemahkan hasil yang sudah diperoleh.

J

Jenjang adalah tingkatan yang dapat menggambarkan suatu perkembangan, kemajuan atau status dalam berbagai aspek.

K

Kritis adalah keadaan atau kondisi kesehatan seseorang dalam keadaan parah dan membahayakan jiwa dan membutuhkan bantuan medis segera.

Kognitif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan persepsi atau pemahaman yang melibatkan pikiran dan otak manusia.

Komorbiditas adalah kondisi medis yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu

Koping adalah cara seseorang untuk mengatasi situasi tekanan.

Komprehensif adalah menyangkup banyak hal yang menyeluruh dan luas.

M

Multidimensi adalah cara pandang Kesehatan yang luas dan mengandung semua aspek.

Manajemen adalah rangkaian Tindakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Multiplikatif adalah kemampuan atau kegiatan memperbanyak untuk mencapai hasil yang diinginkan

N

Non Farmakologi adalah tindakan kesehatan yang tidak membutuhkan obat-obatan.

O

Obesitas adalah kondisi kelebihan berat badan normal.

P

Psikologis adalah kondisi kesehatan mental seseorang yang harus segera ditangani oleh tenaga medis, psikolog maupun psikiater

Prognosis adalah perkiraan atau prediksi terkait kemungkinan kondisi medis tertentu.

R

Reseptor adalah bagian dari sistem syaraf sebagai penerima rangsangan dari luar maupun dalam tubuh dan mengubah

S

Stadium adalah tingkat keparahan suatu penyakit yang merujuk pada penyebaran asal penyakit

Subjektif adalah hal-hal yang didasari pada pandangan atau perasaan seseorang

T

TOUS adalah teori keperawatan yang membahas tentang tanda gejala kondisi kesehatan seseorang.

V

Vaskuler adalah merupakan pembuluh darah yang ada pada tubuh makhluk hidup.

W

WHO adalah badan kesehatan dunia yang membahas tentang kesehatan dunia baik panduan, promosi kesehatan maupun pencegahan penyakit.

PROFIL PENULIS



Lia Fadlilah, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Rembang, 04 Juli 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2015. Melanjutkan jenjang profesi Ners pada program studi profesi Ners, Universitas Islam Sultan Agung tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Safin Pati mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah; Kebutuhan Dasar Manusia; Falsafah dan Teori Keperawatan dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: liafadlilah952@gmail.com

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.

Lahir di Sukabumi, 17 Desember 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 minat Biostatistik dari Universitas Airlangga pada tahun 2005 dan menyelesaikan studi S3 Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2015. Dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada 26 Juli 2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Airlangga mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Biostatistik dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi Nasional dan Internasional, seminar Nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tintin-s@fkip.unair.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep., Ns., M.Kep) Lahir di Blitar, 16 Juni 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S-1 Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Airlangga tahun 2004. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 dari Universitas Airlangga pada tahun 2010 dan menyelesaikan studi S3 Ilmu Kedokteran

Universitas Airlangga pada tahun 2015. Saat ini penulis bekerja di Universitas Airlangga mengampu mata kuliah Keperawatan Jiwa, Jiwa lanjut dan masalah psikososial baik pada kelompok sehat, resiko dan gangguan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi Nasional dan Internasional, seminar Nasional dan Internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hanik-e-n@fkip.unair.ac.id

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas manajemen nyeri pasien kanker payudara dalam Upaya untuk meningkatkan kenyamanan. Kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak di dunia setelah kanker paru-paru. Sebagian besar pasien yang didiagnosis dengan kanker payudara akan mengalami efek dari rangkaian pengobatan atau disebabkan oleh proses penyakit itu sendiri. Salah satu gejala yang paling umum dialami yaitu nyeri.

Nyeri kanker melibatkan komponen fisik, sosial, psikologis dan spiritual yang biasa disebut dengan nyeri yang bersifat multidimensi. Nyeri yang tidak dikelola dengan baik dan tidak berangsur berkurang dapat berdampak pada fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kontribusi masing-masing komponen bervariasi berdasarkan faktor individu dan keadaan yang dihadapi pasien. Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kenyamanan merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan yang dapat dicapai melalui perawatan yang berpusat pada pasien. Selain itu, kenyamanan adalah konsep holistik yang perlu diimplementasikan oleh tim keperawatan multidisiplin. Pengendalian nyeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara. Manajemen nyeri non farmakologis dalam kenyataannya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi perawat, hal ini berkaitan dengan perbedaan persepsi nyeri yang dialami oleh pasien.

Buku ini tidak hanya untuk tenaga keperawatan, tetapi dapat digunakan sebagai tambahan wawasan tenaga Kesehatan lain, organisasi terkait, keluarga pasien kanker payudara dan juga Masyarakat umum dalam Upaya meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara melalui manajemen nyeri.

Buku ini membahas manajemen nyeri pasien kanker payudara dalam Upaya untuk meningkatkan kenyamanan. Kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak di dunia setelah kanker paru-paru. Sebagian besar pasien yang didiagnosis dengan kanker payudara akan mengalami efek dari rangkaian pengobatan atau disebabkan oleh proses penyakit itu sendiri. Salah satu gejala yang paling umum dialami yaitu nyeri. Nyeri kanker melibatkan komponen fisik, sosial, psikologis dan spiritual yang biasa disebut dengan nyeri yang bersifat multidimensi. Nyeri yang tidak dikelola dengan baik dan tidak berangsur berkurang dapat berdampak pada fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kontribusi masing-masing komponen bervariasi berdasarkan faktor individu dan keadaan yang dihadapi pasien. Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaknyamanan. Kenyamanan merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan yang dapat dicapai melalui perawatan yang berpusat pada pasien. Selain itu, kenyamanan adalah konsep holistik yang perlu diimplementasikan oleh tim keperawatan multidisiplin. Pengendalian nyeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara. Manajemen nyeri non farmakologis dalam kenyataannya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi perawat, hal ini berkaitan dengan perbedaan persepsi nyeri yang dialami oleh pasien. Buku ini tidak hanya untuk tenaga keperawatan, tetapi dapat digunakan sebagai tambahan wawasan tenaga Kesehatan lain, organisasi terkait, keluarga pasien kanker payudara dan juga Masyarakat umum dalam Upaya meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara melalui manajemen nyeri.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

